

DEXTOS®

Bromhidrato de dextrometorfano

Eficaz efecto
antitusivo¹⁻⁶ e inicio
rápido de la acción
(15-30 minutos).¹

Duración aproximada
de la acción de 5-6 horas.¹

Buena
tolerabilidad.^{6,7}

Agradable
sabor a naranja.¹

PARA
LA TOS SECA
E IRRITANTE.¹



Bial

1. Resumen de las características del producto DEXTOS® 2. Dipningitis, P.V., Colce, G.L., Goolsby, M.J. et al. Cough 2009; 11: 3. Madison J and Irwin R. Otolaryngologic Clinics of North America 2010; 43:1: 1-13. 4. Song WJ, Chang YS et al. Eur Respir J. 2015 May;45(5):1479-81. 5. Ramsay J, et al. Br J Clin Pharmacol 2008;65(5):737-41. 6. Matthys H, et al. J Int Med Res 1983;11(2):92-100. 7. Shin EJ, et al. J Pharmacol Sci 2011;116:137-48

Nombre del medicamento: DEXTOS, 27 mg/15 ml, jarabe. Composición cualitativa y cuantitativa: 27 mg de bromhidrato de dextrometorfano por 15 ml de jarabe. **Indicaciones terapéuticas:** DEXTOS es utilizado en el tratamiento sintomático de la tos improductiva causada por irritación de las vías respiratorias altas o bajas. **Farmacología y forma de administración:** En adultos y adolescentes (mayores de 12 años): 15 ml cada 6 o 8 horas. Dosis máxima diaria recomendada de 60 ml. En niños de 2 a 5 años: la posología será según indicación médica. Niños menores de 2 años: no se recomienda su utilización. No sobrepasar las dosis recomendadas o utilizar por periodos largos. El jarabe puede tomarse diluido en agua o sin diluir. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a alguno de los excipientes. Tos productiva. Tratamiento concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO). **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** DEXTOS debe administrarse con precaución en pacientes asmáticos o atópicos, y también en pacientes sedados o debilitados, puesto que puede desarrollar liberación de histamina. Debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática ya que puede alterarse el metabolismo del dextrometorfano. Se han notificado casos de consumo excesivo y dependencia de dextrometorfano. Se recomienda especial precaución en adolescentes y adultos jóvenes, así como en pacientes con antecedentes de abuso de drogas o sustancias psicoactivas. Si la tos persiste más de una semana, si reaparece o si va acompañada de fiebre alta, erupción en la piel o cefaleas intensas, un médico debe ser consultado. DEXTOS contiene 121,64 g de sacarosa por cada 200 ml de jarabe. Una dosis de 15 ml contiene aproximadamente 9,123 g de sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción a la glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. DEXTOS contiene 2,75 g de etanol al 96% por cada 200 ml de jarabe. Una dosis de 15 ml contiene aproximadamente 0,20 g de etanol al 96%. Este medicamento contiene aproximadamente 192 mg de alcohol (etanol) en cada 15 ml. La cantidad en 15 ml de este medicamento es equivalente a menos de 5 ml de cerveza o 2 ml de vino. La pequeña cantidad de alcohol que contiene este medicamento no produce ningún efecto perceptible. Puede provocar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). El dextrometorfano se metaboliza por el citocromo hepático P450 2D6. La actividad de esta enzima está determinada genéticamente. Alrededor del 10 % de la población general son metabolizadores lentos de CYP2D6. Los metabolizadores lentos y los pacientes que usen inhibidores de CYP2D6 de forma concomitante pueden experimentar efectos del dextrometorfano aumentados o prolongados. Por lo tanto, se debe tener precaución en pacientes que son metabolizadores lentos de CYP2D6 o usan inhibidores de CYP2D6 (ver también la sección 4.5). Síndrome serotoninérgico: Se han comunicado efectos serotoninérgicos, incluida la aparición de síndrome serotoninérgico potencialmente mortal, para dextrometorfano con la administración concomitante de agentes serotoninérgicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), fármacos que afectan al metabolismo de la serotonina (incluidos los inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO)) y los inhibidores de CYP2D6. El síndrome serotoninérgico puede incluir cambios en el estado mental, inestabilidad autonómica, anomalías neuromusculares y síntomas gastrointestinales. Si se sospecha la presencia de síndrome serotoninérgico, se debe suspender el tratamiento con DEXTOS. Población pediátrica: Pueden producirse reacciones adversas graves en niños en caso de sobredosis, incluyendo trastornos neurológicos. Se debe advertir a los cuidadores que no excedan la dosis recomendada. **Interacción con otros medicamentos:** Inhibidores de la IMAO: uso contraindicado; Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS): con la administración concomitante, es posible que los dos agentes compitan entre sí y se inhiban mutuamente sus metabolismos, incrementando las concentraciones séricas de ambos los fármacos; Tioridazina: debe evitarse el uso; Antiarrítmicos: puede incrementar la concentración sérica de dextrometorfano con un incremento de sus efectos adversos; Alcohol: debe evitarse; Haloperidol: puede provocar concentraciones elevadas de dextrometorfano y un incremento de los efectos adversos; Medicamentos depresores del sistema nervioso central: pueden potenciar los efectos del dextrometorfano; Inhibidores de CYP2D6: el uso concomitante puede aumentar las concentraciones de dextrometorfano y potenciar sus efectos adversos; **Fertilidad, embarazo y lactancia:** DEXTOS no está recomendado durante el embarazo y la lactancia. **Efectos adversos:** son raros, pudiendo manifestarse, a veces, trastornos gastrointestinales, tales como náuseas y vómito, dolores de estómago, mareos y vértigo. **Sobredosis:** puede estar asociada con náuseas, vómitos, distonía, agitación, confusión, somnolencia, estupor, nistagmo, cardiotoxicidad (taquicardia, ECG anormal incluida prolongación de QTc), ataxia, psicosis tóxica con alucinaciones visuales, hiperexcitabilidad. En caso de sobredosis masiva se pueden observar los siguientes síntomas: coma, depresión respiratoria, convulsiones. Tratamiento: Se puede administrar carbón activo a pacientes asintomáticos que hayan ingerido una sobredosis de dextrometorfano en la hora anterior. Para pacientes que han ingerido dextrometorfano y están sedados o en coma, se puede considerar, naloxona a las dosis habituales para el tratamiento de sobredosis de opiáceos. Se pueden usar benzodiacepinas para las convulsiones y benzodiacepinas y medidas de enfriamiento externo para la hipertermia por síndrome serotoninérgico. **Presentación:** Frasco de vidrio con 200 ml de jarabe. Incluye un vaso dosificador. **Titular de la autorización de comercialización:** BIAL – Portela & Cª, S.A. – Á. Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal. **Fecha de la revisión del texto:** Julio 2021 Lea detenidamente toda la información indicada en el etiquetado exterior y en el prospecto. En caso de duda o si los síntomas persisten o aparecen otros síntomas, informe a su médico o farmacéutico. **DMgMA_PT211227**

biallatam.com